جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : انشراح على السيد على
المحافظة : القليوبيه **الحي / المدينة :** القناطر الخيريه **العنوان :** *-*-
رقم البطاقة : 29508301400988 **رقم التليفون :** 01210453566 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 15-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 30-08-1995 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: انشراح على السيد على
National ID: 29508301400988

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Supportive and palliative Treatment**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]
National ID – Front & Back



بطاقة تحقيق الشخصية

انشراح
على السيد على فتح الباب

بهادة
مركز القناطر الخيرية - القليوبية

٢٩٥٠٨٣٠١٤٠٠٩٨٨

١٩٩٥/٠٨/٣٠

JM5478001

١٤/٥/١٩



٢٠٢٢/٠٨

٢٩٥٠٨٣٠١٤٠٠٩٨٨

بدون عمل

متزوجة

انثى مسلمة

احمد ابراهيم محمد كامل

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٨/٠١

مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال-مصر
Children's Cancer Hospital Foundation - Egypt
57357

Nuclear Medicinine Dept.
PET/CT Unit

Name: Ensherah Ali elsayed
Referred by: Prof.

Date: 13/9/2026
ID: 30216522

F18-FDG PET/CT STUDY

Clinical History:

- New case with thyroid nodule

Reason for PET/CT study:

- Initial assessment.

Technique:

- Radiopharmaceutical: 18F FDG.
- PET/CT images were acquired from the skull base through the upper thighs & CT images were acquired for the purpose of anatomical localization and attenuation correction. Images were reviewed in the transaxial, coronal, and sagittal planes.
- Additional notes: SUV max normalized to body weight was used.

COMPARISON: No previous PET CT studies.
Reference hepatic activity is of SUVmax 1.8.

[[DOCTYPE:PET_SCAN]]
PET Scan

FINDINGS:

Head and Neck:

- **No FDG avid thyroid nodules**
- No hyper-metabolic FDG avid cervical LNDs
- Physiologic FDG uptake is seen in the oropharynx, salivary glands, and larynx.
- Normal diffuse brain activity with NO hypermetabolic brain lesions.

Chest:

- There is no hypermetabolic mediastinal or axillary lymphadenopathy.
- NO FDG avid lung nodules or masses detected.
- No metabolically active pericardial or pleural lesions detected.
- Physiologic FDG uptake is noted in the heart.

Abdomen and Pelvis:

- There is no hypermetabolic abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- The liver is mild enlarged size and homogenous parenchymatous texture with NO FDG avid focal lesions detected.
- The spleen is of average size with NO FDG avid focal lesions detected.
- The pancreas shows normal FDG avidity.
- There are no active adrenal nodules.
- Physiologic FDG excretion is seen in the kidneys and bladder

[[DOCTYPE:PET_SCAN]]
PET Scan

Musculoskeletal:

- Normal FDG activity is seen over the axial skeleton. No focal active blastic or lytic bone lesions detected.

IMPRESSION:

No evidence of hypermetabolic active thyroid nodules, for correlation with US.

No evidence of hypermetabolic active focal lesions distinctive for active neoplasia.

Thanks for referral,

Eman Moussa, MD
Radiology Consultant

Rehab Maklad, MD
Nuclear Medicine Consultant

[[DOCTYPE:ULTRASOUND]]
ultrasound

Al – Azhar University
Al – Hussein Hospital
Radiology Department

جامعة الأزهر
مستشفى الحسين الجامعي
قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية

Patient Name: Ensherah Ali
Date: Tuesday, June 23, 2026

NECK U/S

- *Both thyroid lobes and isthmus are Shows average size, homogenous parenchyma, average vascularity no solid or cystic nodules no retrosternal extensions.*
- *The gland moves freely with deglutition.*
  - *Right lobe measures about 15 mm in AP diameter.*
  - *Left lobe measures about 14mm in AP diameter.*
  - *Isthmus measures about 5 mm in AP diameter.*
- *Normal size, shape, of both Submandibular salivary glands*
- *Normal parotid glands with no masses*
- *Normal appearance of the cervical great vessels.*
- *Bilateral enlarged non-specific upper deep cervical &submandibular lymph node 12 x 2.9mm in diameters and the largest submandibular measures about 11x5 mm.*

Conclusion:

- *Bilateral enlarged non-specific upper deep cervical &submandibular lymph node*

WITH MY BEST REGARDS
Dr. Amr Ezz

ا.د. أحمد كمال الدر
ا.د. محمد أبو الهدى درويش
ا.د. عمر حسين عم
ا.د. وحيد حسين طنطاو
أساتذه الأشعة التشخيصية
كلية الطب - جامعة عين شمس

NAME: ENSHERAH ALY EL SAED ALY PATIENT ID: 1249632
STUDY DATE: 30/01/2025

DEAR SIR

NECK SONOGRAPHY REVEALED:

- Both thyroid lobes and the isthmus are of average size displaying homogenous echopattern .
- Thyroid isthmus shows a tiny solid hypoechoic nodule measuring 2.8 x 3.5 mm (TIRADS 3)
  - Right lobe measures 14x15 x 44 mm
  - Left lobe measures 13x 15x 43 mm
- No retro-sternal extension.
- Central trachea.
- Bilateral cervical reactional lymph nodes are seen with preserved oval shape and fatty hilum the largest measures 4x14 mm .
- No suspicious cervical lymphadenopathies
- Normal appearance of the neck vessels.

CONCLUSION:

- Tiny thyroid isthmus nodule (TIRADS3) for follow up
- Reactive enlarged cervical lymph nodes otherwise normal study.

MUCH OBLIGED

A.PROF. OMAR FAROUK

طبيب الوحدة د. منها حامد

Visit Number	38724517250
Patient Name	[illegible]
Age / Sex	30 Year Female
Referred By	Prof : [illegible]
Client Name	18947

Registered [illegible]
Collected 29-12-202[illegible]
Authenticated 30-12-2024 [illegible]
Printed [illegible] 2024 08:06 5[illegible]

TEST NAME	RESULT	UNIT	REFERENCE RANGE
Thyroid Function Tests			
TSH	1.64	uIU/mL	0.55 - 4.78

Assay Method: CLIA/ECLIA
Many factors affect TSH levels including circadian rhythm (peak around midnight and a low in the afternoon), diet
(ber Diet or Goitrogenic Foods), thyroid therapy, autoimmune thyroiditis and stress. Such factors act as Non-thy
ness affecting TSH levels without any effect on thyroid gland.

toimmune Thyroid Disease Profile

ti- Thyroid Antibodies

ti Thyroglobulin Abs	14.10	IU/mL	0 - 115
ti Thyroid Peroxidase Abs	12.2	IU/mL	0 - 34

ay Method: CLIA/ECLIA

Dr. Manal Kamal
Professor of Clinical & Chemical Pathology
Faculty of Medicine, Cairo University

اسم الفرع القناطر الخيريه
مدير الفرع الدكتورة/ ريهام اسامه عبد مغاورى
مدير الوحده د. منال كمال
طبيب الوحده د. سها حامد

Visit Number:	38725506858	Registered	18-06-2025 13:24:41
Patient Name:	انشراح على السيد على فتح الباب	Collected	18-06-2025 13:24:56
Age / Sex:	30 Year / Female	Authenticated	18-06-2025 20:41:20
Referred By:	Prof : احمد شهاب	Printed	19-06-2025 14:15:19
Client Name:	18947		

TEST NAME	RESULT	UNIT	REFERENCE RANGE
Thyroid Function Tests			
T3-Total	109	ng/dL	80 - 200
Assay Method: CLIA/ECLIA			
T4-Total	7.8	ug/dL	5.1 - 14.1
Assay Method: CLIA/ECLIA			
TSH	1.88	uIU/mL	0.55 - 4.78
Assay Method: CLIA/ECLIA			

TSH is a pituitary hormone secreted in a pulsatile manner causing fluctuations over minutes.

Many factors affect TSH levels including circadian rhythm (peak around midnight and a low in the afternoon), diet (high fiber diet or goitrogenic food) , thyroid therapy , autoimmune thyroiditis and stress . Such factors act as Non thyroidal illness affecting TSH levels without any effect on thyroid gland. Different testing methods can yield to varying results.

Dr. Manal Kamal
Professor of Clinical & Chemical Pathology
Faculty of Medicine, Cairo University

Scan Me